

LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS (DOAC)

Mode d'action

Le dabigatran est un inhibiteur direct de la thrombine

Le rivaroxaban et l'apixaban sont des inhibiteurs du facteur Xa.

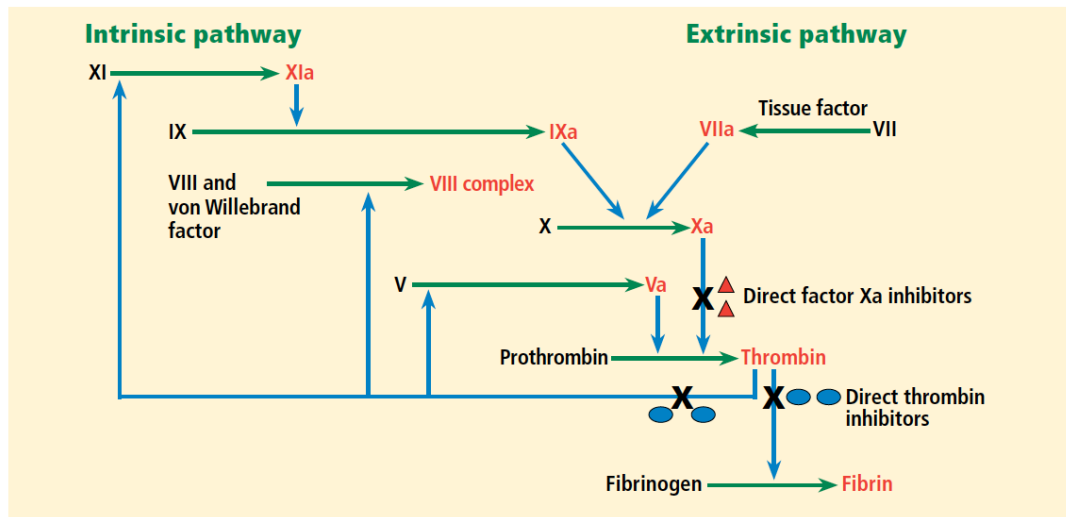


FIGURE 1. The coagulation cascade and how the new oral anticoagulants block it.

Fawole A et al. Cleve Clin J Med 2013;80:443

Accès libre : <http://www.ccm.org/content/80/7/443.full.pdf+html>

Indications cardiovasculaires

Apixaban et rivaroxaban :

Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l'embolie pulmonaire (EP)

Prévention de la TVP chez les patients adultes après une prothèse de la hanche ou du genou

Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie systémique en cas de fibrillation auriculaire (FA) non valvulaire

Dabigatran

Traitement et prévention de TVP et de l'EP

Prévention de L'AVC) et de l'embolie systémique en cas de FA non valvulaire

Les données actuelles comparant l'efficacité et la sécurité des DOAC vs les agents anti-vitamine K pour la prévention des AVC et embolies systémiques chez les patients souffrant de FA montrent que les DOAC présenteraient un profil bénéfice/risque identique voire légèrement supérieur à celui des agents anti-vitamine K (moins de saignements cérébraux mais plus de saignements gastro-intestinaux). Les données actuelles ne permettent pas de déterminer quel est le meilleur DOAC en fonction du profil du patient et chez quel patient il convient de prescrire un DOAC à la place des agents anti-vitamine K.

Caractéristiques pharmacocinétiques

	Dabigatran	Rivaroxaban	Apixaban
Transporteurs	P-gp	P-gp, BCRP	P-gp, BCRP
t _{1/2} (h)	14-17	7-11	8-14
Métabolisme hépatique	Conjugaison	CYP450	CYP450
Élimination rénale	>80% inchangé	30% inchangé	30% inchangé

P-gp=glycoprotéine P ; **BCRP**=Breast cancer resistance protein

Rappel: les transporteurs P-gp et BCRP jouent un rôle important dans l'absorption (intestin), l'élimination (foie et reins), et la distribution (barrière hémato-encéphalique et placentaire) des médicaments.

Effets indésirables

Type A

Saignements.

Contre-indications

Dabigatran : Insuffisance rénale sévère (ClCr <30 ml/min).

Apixaban et rivaroxaban: insuffisance hépatique modérée ou sévère.

Saignement actif.

Valves cardiaques artificielles.

Interactions médicamenteuses

PK : Dabigatran, apixaban et rivaroxaban : traitement concomitant avec un inhibiteur de la P-gp (augmentation des concentrations donc du risque de saignements) ou avec un inducteur de la P-gp (diminution de l'effet).

Apixaban et rivaroxaban : traitement concomitant avec un inhibiteur ou un inducteur du CYP3A4.

PD : augmentation du risque hémorragique en cas d'association avec des antiplaquettaires, anticoagulants et AINS.

Remarques

Actuellement il n'existe pas : de méthode validée pour quantifier leur effet anticoagulant.

Il existe un antagoniste spécifique pour le dabigatran : l'idarucizumab

L'idarucizumab est un fragment d'anticorps monoclonal humanisé qui se lie au dabigatran uniquement supprimant ainsi l'effet anticoagulant chez les patients qui présentent une hémorragie incontrôlable ou qui nécessitent une procédure invasive urgente.

L'adexanet, antagoniste des inhibiteurs du facteur Xa a été enregistré aux USA et est en attente d'enregistrement en Suisse (Bulletin OFSP du 06.02.2018).